Síndrome piramidal, extrapiramidal y vascular

SEMIOLOGIA · Clase 39 · vía corticoespinal, Parkinson, territorios arteriales y Wallenberg

1 · LA VÍA PIRAMIDAL Y CÓMO SE INTERRUMPE

Vía piramidal (corticoespinal)
es la primera neurona motora: manda el movimiento voluntario y frena los reflejos; el 85-90 % de sus fibras cruza en el bulbo (75 % en el apunte de 2018)

si una lesión la interrumpe, los…

F5
Causas de la lesión (literatura)
traumatismo; vascular (hemorragia por HTA o aneurisma, isquemia por trombosis, embolia o vasculitis); compresión (tumores, quistes); infección (meningoencefalitis, abscesos)

al actuar sobre la vía producen la

F1 · F2
Lesión de la primera neurona motora
el nivel interrumpido decide si el déficit es mono-, hemi-, para- o cuadripléjico

según el nivel interrumpido da

si es vascular en el bulbo lateral

2 · LIBERACIÓN PIRAMIDAL: TIESO, HIPERREFLÉXICO Y EN GUADAÑA

F2
Paresia o plejía
pérdida parcial o total de la fuerza; central: espástica, sin atrofia

si la lesión es periférica, en cambio

F2
Si la lesión es periférica (motoneurona inferior)
parálisis flácida con hipo- o arreflexia y atrofia

en la cápsula interna va apretada:

pierde el freno y ocurre la

Liberación piramidal
sin el freno cortical la motoneurona inferior responde de más; en lo agudo hay primero flacidez

en el tono da

en los reflejos da

en la piel del abdomen abole los

F1 · F2
Espasticidad en navaja
la resistencia inicial cede de golpe al estirar el miembro

F1
Hiperreflexia, clonus, Babinski y Hoffman
los reflejos quedan liberados

F1 · F2
Reflejos cutáneo-abdominales abolidos

predomina en los músculos

no confundir con liberación frontal:

junto a la hiperreflexia confirma el

F3
Músculos antigravitatorios
la espasticidad predomina en flexores del brazo y extensores de la pierna (literatura)

F11
Signo de Marinesco (literatura)
reflejo palmomentoniano: al rascar la eminencia tenar se contrae la borla del mentón; liberación frontal, no dolor localizado

confirma el

apoya el

a diferencia de la

al caminar produce la

F3
Marcha en guadaña (del segador)
brazo flexionado, pierna extendida que traza un semicírculo; con el tiempo, hipotrofia por desuso

separa del piramidal y orienta el

se reconoce de lejos el

Síndrome piramidal reconocido
lesión de la primera neurona motora: débil, espástico y con Babinski

frente a los otros dos se resume en

3 · QUÉ PARTE SE PARALIZA: CÁPSULA, CORTEZA Y ARTERIAS

F4
Cápsula interna
todas las fibras pasan juntas: una lesión pequeña da hemiplejia contralateral proporcionada (cara, brazo y pierna)

por eso su lesión confirma el

en la corteza va desplegada:

F4 · F6
Corteza (homúnculo)
la vía está desplegada: una lesión toma solo una parte del cuerpo; el territorio arterial decide cuál (literatura)

si se tapa la cerebral media, da la

si se tapa la cerebral anterior, da la

F6
Cerebral media
riega la cara lateral: déficit faciobraquial contralateral

F6
Cerebral anterior
riega la cara medial: afecta la pierna

si cede en menos de 24 horas es un

un déficit izquierdo implica lesión

el déficit queda en la pierna: es un

F6
Ataque isquémico transitorio
el déficit se recupera en menos de 24 horas (literatura)

F6
Déficit izquierdo
implica lesión del hemisferio derecho (contralateral)

localiza el hemisferio en el

se resuelve como un

Déficit vascular localizado
la arteria decide qué parte del cuerpo se paraliza

junto con el patrón motor orienta el

4 · BULBO LATERAL: ATAXIA, HORNER Y DISFAGIA SIN PIRAMIDALISMO

F7
Infarto dorsolateral del bulbo
territorio de la arteria vertebral o la PICA (literatura)

compromete el bulbo y sus

F7
Estructuras del bulbo lateral
núcleo ambiguo, vía simpática y conexiones cerebelosas; las pirámides van delante y se respetan

da, del mismo lado, el

F7
Síndrome de Wallenberg
ataxia, Horner, disfonía y disfagia del mismo lado

como las pirámides se respetan, hay

sin hemiplejía deja el

Bulbo lateral localizado
sin piramidalismo: no hay hemiplejia ni Babinski

6 · CÓMO SEPARAR LOS TRES SÍNDROMES MOTORES

Cerebeloso
fuerza conservada pero torpe: hipotonía, marcha atáxica y temblor de intención 2-5 Hz

completa la comparación en

Cómo diferenciar
piramidal: débil con Babinski;
extrapiramidal: fuerte pero rígido y lento;
cerebeloso: fuerte pero torpe

permite el

Síndrome motor localizado
el patrón de tono, fuerza y reflejos indica dónde está la lesión

si aparece con la acción es el

5 · EXTRAPIRAMIDAL: RÍGIDO Y LENTO PERO FUERTE

F9
Ganglios basales
se desequilibra la dopamina y los circuitos motores; la sustancia negra pierde su pigmento

en el tono produce

F8
Rigidez en rueda dentada
la muñeca cede a saltos, igual en todo el recorrido

junto a los demás signos define el

F8
Temblor de reposo
4-6 Hz, «cuenta monedas»; desaparece con el sueño

completa el

F8 · F10
Reflejos posturales perdidos y marcha parkinsoniana
pasitos cortos, encorvado y sin braceo

completa el

en el equilibrio y el paso

respeta la vía piramidal:

en el inicio del movimiento

F8 · F10
Bradicinesia
lentitud para iniciar el movimiento con facies inexpresiva

en fases avanzadas lleva a la

F8
Fuerza conservada
no hay debilidad: eso lo separa del piramidal

en reposo produce

lo separa del piramidal en el

F9
Demencia y caídas
llegan en las fases avanzadas, no al inicio

marca el curso del

frente al piramidal se resume en

F10
Síndrome parkinsoniano reconocido
enfermedad de Parkinson: rígido y lento, pero fuerte

años antes puede avisar con

F9 · F10
Aviso precoz (literatura)
estreñimiento y trastorno del sueño REM, años antes

adelanta el diagnóstico del

en el Parkinson empieza con

F10
Comienzo asimétrico
rigidez y lentitud de un solo lado

orienta al

en su forma hipercinética

F8
Grupo hipercinético
corea, atetosis, hemibalismo, tics y distonía

también nace en los ganglios:

concepto · causa · mecanismo · signo · diagnóstico · ejemplo · síndrome · síntoma · complicación · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 11e y 11b · Sotomayor — teoría del docente (= literatura)